利用可能性バイアス

「思い込み」が判断を狂わせる — 利用可能性バイアスと医療安全

全スタッフ向け勉強会スライド（10分）

参考文献

2026-03-29 · AI（Claude）作成・主な出典は原典で確認

最近こんなことありませんか？

「先週ノロウイルスの患者さんが続いた後、今日も嘔吐の患者さんが来たら…つい "またノロかな" って思いませんか？」

- 誰にでも起こる「思い込み」の正体を知りましょう
- 1015名の医師を対象にした最新研究が、この「思い込み」の影響を数字で示しました

今日のゴール

この勉強会の後、あなたは以下ができるようになります:

1. **説明できる**:「利用可能性バイアス」が何かをざっくり説明できる
2. **気づける**: 自分の仕事の中で「思い込み」が起きやすい場面を1つ挙げられる
3. **やってみる**: 明日から使える「思い込み防止」のコツを1つ実践できる

私たちの脳は「ショートカット」が大好き

- 人間の脳には2つのモードがある:
  - **速い脳（直感モード）**：パッと判断する。普段はこちらが大活躍
  - **遅い脳（じっくりモード）**：よく考えて判断する。時間とエネルギーが必要
- 忙しい医療現場では「速い脳」に頼りがち → これ自体は悪いことではない
- ただし「速い脳」には **思い込みのクセ（＝認知バイアス）** がある

利用可能性バイアスってなに？

ひとことで言うと：「最近見たもの・印象に残ったもの」を、実際よりも多いと思い込むこと

日常の例：

- 飛行機事故のニュースを見た直後 → 飛行機が怖くなる（実際は車の方が危険）
- 最近テレビで食中毒の報道 → いつもより食品の鮮度が気になる

医療現場の例：

- 先週インフルエンザを5人診た → 今週も似た症状はインフルエンザだと思いやすい
- 前回の夜勤で転倒事故があった → 今日は転倒にだけ注意が向く

最新研究が示した結果

BMJ Quality & Safety（2026年2月）の研究

- **対象**: 世界の医師1015名
- **わかったこと**:

発見	意味
直近7日以内に同じ病気の患者を診た医師は誤診率が有意に上昇	最近の経験が判断を歪める
経験年数の影響は一様ではない（専門医では10年以上で誤診が少なかった）	経験の年数だけでなく、専門性やフィードバックが関わる
著者らは「構造化されフィードバックの豊富な経験」が重要と考察（本研究で直接測定した結果ではない）	振り返りの習慣が大事かもしれない

ポイント: 「たくさん経験していれば大丈夫」とは限らない

医師だけの話？ ― 全職種に起きる「思い込み」

看護師の場面：

- 最近転倒が続いたユニット → 「またこの患者さんも転ぶかも」と身体拘束の判断に影響
- 前のシフトで急変があった → 今日のバイタル変動を過剰に心配する

薬剤師の場面：

- 最近処方ミスを発見した薬剤 → その薬ばかりに注意が向き、他の薬のチェックが甘くなる

事務・管理部門の場面：

- 最近クレームが多かった部署 → その部署の問題ばかりが目につく

思い込みは全職種に起きます。だからこそチームで対策する意味がある

グループトーク（ 3分間）

近くの人と話してみましょう:

> *「最近、"前と同じだろう" と思って判断したことはありますか？その判断は正しかったですか？」*

- 2-3人グループで
- 正解・不正解は気にせず、「あるある」を共有しましょう

共有タイム

グループで出た「あるある」を1-2グループから共有してもらいましょう。

ファシリテーターからのまとめ：

- 「思い込み」は能力の問題ではなく、脳の仕組みの問題
- だから「気をつけよう」だけでは防げない → **仕組み**が必要

まとめ

明日から使える3つのコツ

コツ	やること	所要時間
立ち止まる	判断する前に「本当に？前回と同じとは限らないよね」と自問する	5秒
声に出す	「私は○○だと思う。他の可能性は？」と同僚に一言聞く	30秒
書き出す	判断に迷った場面をメモしておき、後で振り返る	1分

今週1つだけ試してみましょう。どれを選びますか？

まとめ

まとめと振り返り

今日のポイント：

- 「利用可能性バイアス」＝ 最近の経験が判断を歪めること
- 経験の年数に加えて、**振り返りとフィードバックの習慣** が防御策になりうる
- 一人で頑張るのではなく、**チームで声をかけ合う文化** が大事

確認：隣の人に「利用可能性バイアスって何？」を30秒で説明してみましょう

参考文献

Moura EC et al. (2026) "Evidence of availability bias in diagnostic reasoning following real clinical encounters: a cross-sectional survey of physicians." BMJ Quality & Safety. DOI: 10.1136/bmjqs-2025-019520

Chatterjee et al. "When caution becomes harm: Understanding the psychology of over-investigation." The American Journal of Medicine. 2026;139(2):154-160. DOI: 10.1016/j.amjmed.2025.10.013

Kahneman D. (2011) "Thinking, Fast and Slow"（邦訳: ファスト&スロー）